جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : هويدا زكي محمد المدبولي
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** السيده زينب **العنوان :** 0000
رقم البطاقة : 26203290100204 **رقم التليفون :** 01007945347 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 29-03-1962 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام اشعه مقطعيه علي البطن والصدر والحوض بالصبغه [11127] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: هويدا زكي محمد المديولى
National ID: 26203290100204

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Contrast-enhanced CT Chest & abdomen and pelvis**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



هويدا
زكى محمد المدبولى
٥ عطفة محمد نسيم - بركة القيل
السيدة زينب - القاهره

٢٩٠٣٠١٠٠٢٠٤

JW2997668

٠١٠٧٩٤٥٣٤٧
٠١٠٢٢١٠٣٢٤٩

٢٩٠٣٠١٠٠٢٠٤ ٢٠٢٣/٠٢
حاصله على بكالوريوس تجاره

أنثى مسلمة أرملة

١ البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/٠٢/١٧

National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Name: Mrs. Nowaida Zaki Mohamed El-Madboly

Date: 27.8.2026 ID:2226029891 Acc.:5294077

Referring Prof. Dr.: Mohamed Salah AlDeen.

Digital 3D soft tissue mammography & tomosynthesis with ultrasound examination of the left breast, revealed:

Indication: left breast palpable lump

Mammography & Tomosynthesis:

- Heterogeneous dense breast parenchyma (ACR-c)
- Lower outer quadrant posterior third heterogeneous dense lesion, the posterior margin of the lesion couldn't be depicted by mammography, about 11 cm distance from the nipple
- No suspicious micro-calcific clusters noted.
- Mild diffuse skin thickness.
- Normal areola / nipple complex.

Ultrasonographic examination showed:

- Heterogeneous background echotexture – (moderate glandular component)
- Lower outer quadrant 4-5 oclock oval shaped heterogeneous hypoechoic solid lesion with indistinct margin measuring 5 x 3.3 x 3.6 cm, parallel orientation, no posterior shadowing, prominent internal vascularity in complementary color Doppler study
- Mild to moderate interstitial edema and skin thickening (up to 11 mm)
- Retro-areolar dilated ducts up to 0.44 cm, with clear anechoic content.
- More than three level I axillary lymph nodes with globular shape, diffuse cortical thickness measuring 2.8 x 2.3 cm, 1.7 cm cortical thickness

Opinion:

- Left breast highly suspicious LOQ lesion with ipsilateral pathologic axillary lymph nodes as described (BIRADS 5)

Recommendation:

- Ultrasound guided biopsy from the left breast LOQ lesion

Dr. Lamiaa Elsharkawy, MD

BI-RADS scoring is the breast imaging and reporting data system for classifying the radiological diagnosis of breast lesions:

- BI-RADS 0: Incomplete – need additional imaging evaluation or comparison with previous films
- BI-RADS 1: Normal examination – nothing to comment on – Routine mammography screening is recommended
- BI-RADS 2: Benign findings – routine mammography screening is recommended
- BI-RADS 3: Probably benign <2% malignancy – short interval follow-up is suggested.
- BI-RADS 4: Suspicious >2 but <95% – Biopsy should be considered
  - 4A: low suspicion of malignancy: 2-20%
  - 4B: Mod suspicion of malignancy: 10-50%
  - 4C: High suspicion of malignancy: 50-90%
- BI-RADS 5: Highly suspicious of malignancy >95% – appropriate action should be taken
- BI-RADS 6: Known – biopsy proven malignancy. Surgical excision when clinically appropriate.

American college of radiology (ACR) scoring of breast density:

- ACR a: almost entirely fatty
- ACR b: scattered areas of fibro-glandular density
- ACR c: heterogeneously dense
- ACR d: extremely dense

Mammogram [DOCTYPE:MAMMOGRAM]